ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Abordaje Fisioterapéutico del Síndrome de Guillain-Barré: Revisión de la Evidencia

Autores: Grupo D *Docente: Nathalie García*
Curso: Tecnicas de intervención I Semestre: Sexto

Introducción

Las alteraciones del movimiento de origen neurológico o neuromuscular comprometen la función motora y la independencia funcional. La fisioterapia, mediante una valoración integral e intervención individualizada, favorece la recuperación funcional, la movilidad y la autonomía del paciente.

Marco Teorico

El síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía autoinmune que provoca debilidad muscular progresiva y limitaciones funcionales, requiriendo fisioterapia para favorecer la recuperación de la movilidad y la independencia.

Objetivos

Objetivo general: Las alteraciones neurológicas afectan la movilidad y la independencia; la fisioterapia favorece su recuperación funcional.

Objetivos específicos: Identificar las alteraciones motoras y las estrategias fisioterapéuticas para mejorar la recuperación funcional en el síndrome de Guillain-Barré.

Metodología de Producción y Datos

Se realizó una revisión de literatura científica y el análisis de un reporte de caso de una paciente de 20 años con síndrome de Guillain-Barré, utilizando hallazgos clínicos, pruebas diagnósticas y evidencia sobre intervención fisioterapéutica.

Resultados de la cartilla

La revisión del caso clínico y de la evidencia científica permitió identificar las principales alteraciones motoras y funcionales del síndrome de Guillain-Barré, así como estrategias de intervención fisioterapéutica pertinentes para su abordaje.

Conclusión

La fisioterapia constituye una estrategia esencial en la rehabilitación del síndrome de Guillain-Barré, al favorecer la recuperación funcional, disminuir la discapacidad y promover la independencia del paciente.

Bibliografías QR

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

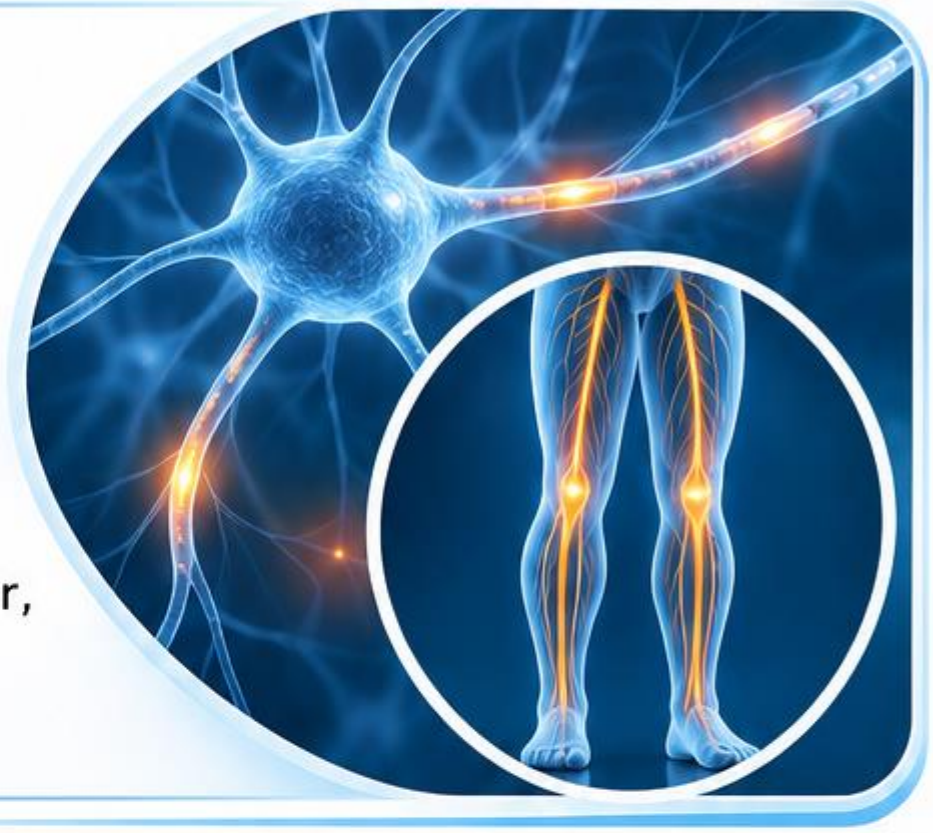
INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una enfermedad autoinmune que afecta los nervios periféricos y puede provocar debilidad muscular, pérdida de fuerza, alteraciones sensitivas y dificultades en el movimiento. Estas alteraciones afectan la movilidad y la independencia del paciente.

Por ello, la fisioterapia cumple un papel fundamental en la rehabilitación, ayudando a recuperar la función muscular, mejorar la movilidad, prevenir complicaciones y favorecer la calidad de vida.



PRESENTACION DEL CASO CLINICO

Según Gawande et al. (2024), se presenta el caso de una paciente diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré, variante AIDP, caracterizada por afectar la mielina de los nervios periféricos.

La paciente presentó debilidad muscular en las cuatro extremidades, mayor en miembros inferiores, flacidez, disminución de reflejos, hormigueo y dolor intenso, acompañado de dificultad para caminar.

En la valoración se encontró una fuerza muscular de 1/5 y dolor de 7/10 en reposo y 9/10 durante el movimiento. Además, los estudios clínicos confirmaron alteraciones neurológicas compatibles con esta enfermedad, evidenciando un importante compromiso de su movilidad y capacidad funcional.

Referencia: Gawande et al. (2024).



ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

Analisis del problema motor

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso periférico, provocando alteraciones en la conducción nerviosa. En la paciente se evidencia debilidad muscular generalizada, hipototonía e hiporreflexia, con mayor compromiso funcional en los miembros inferiores. Estas alteraciones dificultan el control motor, las transferencias, la bipedestación y la marcha, disminuyendo su independencia en las actividades de la vida diaria.



La fisioterapia busca mejorar progresivamente la fuerza muscular, el control postural, la movilidad y la recuperación funcional mediante ejercicios terapéuticos y entrenamiento motor.



ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Evidencia Científica

Título del artículo	Autor (año)	Estrategia o tipo de ejercicio	Frecuencia	Intensidad / dosificación	Tiempo
Effectiveness of Physiotherapy Intervention in Guillain Barre Syndrome: A Case Report	Gawande, Akhuj y Samal (2024)	1. Movilización pasiva de miembros superiores e inferiores. 2. Estiramiento pasivo contract-relax del tendón de Aquiles. 3. Facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), técnica contract-relax en brazos y piernas. 4. Ejercicios isométricos, estabilización rítmica y ejercicios dinámicos de cuádriceps. 5. Fodamiento en cama y transición de acostado a sentado.	1. No se indica frecuencia diaria o semanal. 2. 2 series de 10 repeticiones; frecuencia semanal no indicada. 3. 1 serie de 10 repeticiones; frecuencia semanal no indicada. 4. 1 serie de 10 repeticiones; frecuencia semanal no indicada. 5. No se especifica.	1. 20 repeticiones; pausa de 2 minutos. No se informa la carga. 2. No se especifica fuerza aplicada. 3. No se especifica resistencia aplicada. 4. No se especifica carga ni esfuerzo. 5. Movimientos facilitados; no se cuantifica esfuerzo.	1. No se informa duración total. 2. Mantener 30 segundos y relajar 5 segundos. 3. No se detalla duración de cada repetición. 4. No se especifica tiempo de contracción. 5. No se especifica.
Effects of Daily Living Occupational Therapy and Resistance Exercise on the Activities of Daily Living and Muscular Fitness in Guillain-Barré Syndrome: A Case Study	Ko, Ha y Kang (2017) [9]	Terapia ocupacional para actividades de la vida diaria y ejercicios de resistencia para mejorar la función muscular.	2 sesiones por semana.	Ejercicios de resistencia; no se especifica una carga numérica ni una intensidad estandarizada.	70 minutos por sesión durante 12 semanas.
Supervised, Individualised Exercise Reduces Fatigue and Improves Strength and Quality of Life More Than Unsupervised Home Exercise in People With Chronic Guillain-Barré Syndrome: A Randomised Trial	Shah et al. (2022)	1. Ejercicio supervisado individualizado: fortalecimiento, resistencia y entrenamiento de la marcha. 2. Ejercicios domicilliarios activos, activo-asistidos y de fortalecimiento.	Ambas modalidades: 2 a 3 sesiones por semana.	1. Ejercicio supervisado: ajustado y progresado según la capacidad individual, sin carga numérica común. 2. Ejercicio domiciliario: no se describe una progresión de carga estandarizada.	1. Ejercicio supervisado: 60 minutos por sesión durante 12 semanas; se recomendó continuar en casa hasta el mes 12. 2. Ejercicio domiciliario: 30 minutoe por sesión durante 12 semanas; se recomendó continuar en casa hasta el mes 12.
A Structured Rehabilitation Program for Functional Recovery in Guillain-Barré Syndrome: A Case Report	Animesh Hazari (autor correspon-dencia) (2025)	Movilización pasiva y estiramiento, activación muscular, fortalecimiento progresivo, control del tronco, facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF), movilidad funcional, equilibrio y transferencias.	No se informa una frecuencia global. Se describen series de ejercicios según la actividad.	Movilizaciones: 25–30 repeticiones. Activación y PNF: 3 series de 10–15 repeticiones. Se progresa de pasivo/asistido a activo según evolución.	Estiramientos mantenidos para contracturas de dedos: 10 min. Contracción sostenida con balón sobre la cabeza: 30 s. Programa descrito durante 4 meses.
Exploring the Efficacy of Physiotherapy in Guillain-Barré Syndrome Through Virtual Reality-Based Rehabilitation: A Case Report	Neha P. Arja (autora de correspon-dencia) (2024)	Ejercicios respiratorios y movilidad en cama, facilitación muscular y PNF, fortalecimiento de miembros superiores, tronco y miembros inferiores; entrenamiento funcional, equilibrio, marcha y realidad virtual.	Espirómetro incentivador: 2–3 veces al dia. Caminadora: 3 veces/semana al inicio y progresión a 5 veces/semana.	Movilidad en cama: 10 repeticiones por serie. Facilitación muscular: 5 repeticiones por serie. Fortalecimiento de tronco y estabilidad escapular: 2 series de 10 repeticiones. Cargas de 1 kg, progresando a 2–3 kg en miembros inferiores.	Espirómetro: 10 repeticiones por serie. Realidad virtual: sesiones de 20 min. Programa descrito por 8 semanas, con valoración en semana 10.
Physical Exercise in Guillain-Barré Syndrome: A Scoping Review	Biá etj Eislik (autor de correspon-dencia) (2025)	Fortalecimiento isométrico, isotónico, dinámico y de resistencia; estabilización rítmica; entrenamiento funcional, marcha y equilibrio; ejercicio aeróbico en bicicleta/ cicloergómetro; movilidad, estiramientos, ejercicios respiratorios y PNF.	Algunos programas: 2–3 sesiones por semana.	Fortalecimiento muscular con diferentes tipos de resistencia y estabilización: 2–3 series de 10–15 repeticiones. La intensidad se adapta y progresa según la tolerancia. No se establece una intensidad única para todos los estudios.	Ejercicio aeróbico: aproximadamente 30 min por sesión en algunos programas. La duración total varía entre los estudios incluidos.
Rehabilitation of a Chronic Guillain-Barré Syndrome Patient With Vibratory Motor Stimulation of Dorsiflexors: A Case Report	Agnihotri et al. (2024) [7]	Ejercicios activos y activo-asistidos de miembros superiores e inferiores; fortalecimiento, estabilización abdominal, equilibrio, coordinación y estimulación motora vibratoria de los dorsiflexores.	6 días por semana (lunes a sábado).	Programa individualizado. Estimulación vibratoria: 35 mA, frecuencia de 50 pulsos/s y duración de pulso de 200 µs.	3 horas diarias, incluidos descansos. Estimulación vibratoria durante 20 minutos.
From Critical Care to Community: A Case Report on Guillain-Barré Syndrome Rehabilitation	Mascarenhas et al. (2025) [8]	Rehabilitación respiratoria, facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), fortalecimiento funcional y terapia asistida por robótica.	Programa organizado por fases de recuperación; no se especifica el número de sesiones semanales.	Individualizada, con progresión según la evolución funcional del paciente.	Seguimiento durante 10 meses. La duración de cada sesión no se especifica.

ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Estrategias de intervención

Estrategia

2. Transición de prono a activación de cintura escapular en posición prono en apoyo unilateral y bilateral.

Posición inicial

Paciente: En decúbito prono, asistida para elevar el tronco superior apoyándose sobre los antebrazos y codos.

Fisioterapeuta: En posición semiarrodillada, lateral al paciente, brindando estabilidad y guía.

Puntos claves de control (PCC)

Región torácica media y cintura escapular para evitar el colapso glenohumeral.

Objetivo

Facilitar la extensión activa de la columna cervical y torácica, proporcionar carga axial en las articulaciones de los miembros superiores y mejorar la estabilidad proximal de hombros.

Evidencia fotográfica







ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

USC INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Estrategias de intervención

Estrategia

ESTRATEGIA DE FACILITACIÓN A CUATRO PUNTOS CON APOYO DE ANTEBRAZOS.

Posición inicial

Paciente: Posicionamiento en cuatro puntos modificado a partir de decúbito prono, con apoyo de ambos antebrazos sobre la colchoneta, codos flexionados a 90° alineados bajo los hombros, y caderas y rodillas flexionadas a 90° manteniendo la base de sustentación amplia sobre las rodillas.

Fisioterapeuta: Posición en semi-arrodillado al lado del paciente, garantizando una postura con adecuada estabilidad de tronco.

Puntos claves de control (PCC)

PCC Proximales: Cintura escapular (para favorecer la extensión activa de columna) y cintura pélvica (fijación posterior/lateral de la pelvis para estabilidad).

Objetivo

Favorecer la activación de la musculatura estabilizadora del CORE y la cintura escapular, promoviendo la alineación postural neutra y la tolerancia a la descarga de peso en miembros superiores e inferiores.

Evidencia fotográfica







ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Estrategias de intervención

Estrategia: Posición de cuatro puntos asistida.

Posición inicial	El paciente apoya las manos y las rodillas sobre la colchoneta (manos aproximadamente debajo de los hombros y rodillas debajo de las caderas).
Puntos claves de control (PCC)	El fisioterapeuta estabiliza activamente el tronco y la pelvis, ofreciendo la asistencia necesaria para mantener la postura.
Objetivo	Trabajar la estabilidad proximal, el control de tronco y pelvis, y la tolerancia al apoyo de peso.

Precauciones / progresión: Progresión orientativa: Comenzar con intervalos cortos y una base de apoyo amplia; aumentar el tiempo solo si mantiene buena técnica sin fatiga excesiva.

Evidencia fotográfica







ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Estrategias de intervención

Estrategia

Transición de semiarrodillado a bípedo.

Posición inicial

Paciente: En semiarrodillado, con las palmas apoyadas en una silla a alcance medio y posteriormente a alcance alto.

Fisioterapeuta: Ubicado detrás del paciente, en semiarrodillado.

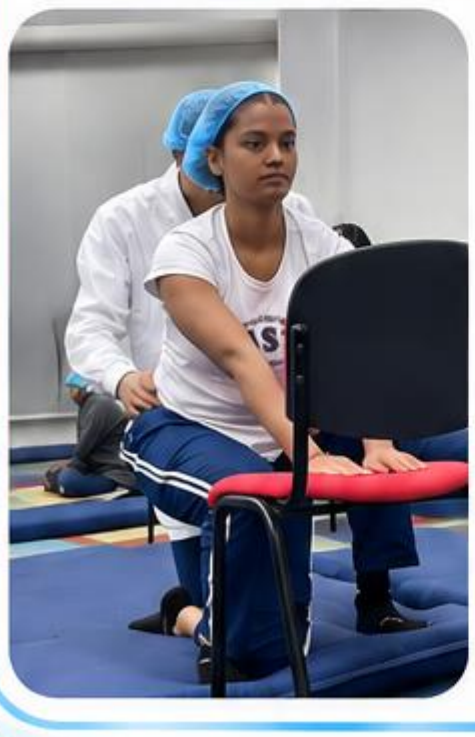
Puntos claves de control (PCC)

Manos del fisioterapeuta ubicadas bilateralmente en la pelvis.

Objetivo

Llevar al paciente desde la posición de semiarrodillado hasta bipedestación.

Evidencia fotográfica






ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Estrategias de intervención

Estrategia

Transferencia asistida de sedente a bípedo y entrenamiento de equilibrio en bipedestación mediante alcance con balón.

Posición inicial

Paciente: Iniciar con el paciente sentado en una silla firme, pies apoyados y tronco orientado hacia el terapeuta.

Fisioterapeuta: El terapeuta se ubica al frente, con contacto de seguridad en pelvis y tronco. Tras ponerse de pie, el paciente permanece frente al terapeuta y realiza alcances hacia un balón, dentro de un rango seguro.

Puntos claves de control (PCC)

- **Pelvis:** guiar el desplazamiento hacia adelante durante el levantamiento y estabilizarla en bipedestación.
- **Tronco:** facilitar extensión axial y control en línea media; evitar tracción del cuello o de los brazos.
- **Rodillas y pies:** controlar alineación y mantener una base de sustentación adecuada.
- **Cintura escapular:** permitir movimiento de brazos para alcanzar el balón sin perder la estabilidad del tronco.
- **Terapeuta:** asegurar la pelvis y el tronco, graduando la asistencia y la distancia del alcance.

Objetivo

Practicar la incorporación a la posición de pie y mejorar el equilibrio estático y dinámico, las reacciones de enderezamiento y el control postural durante actividades de alcance con miembros superiores.

Evidencia fotográfica







ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Estrategias de intervención

Estrategia

Entrenamiento de transferencia de sedente a bípedo con caminador, seguido de estabilización en bipedestación.

Posición inicial

Paciente sentado en una silla estable, con ambos pies apoyados en el suelo y separados al ancho de las caderas. Caminador ubicado al frente y frenado/estabilizado por el terapeuta. El terapeuta se coloca al lado o ligeramente detrás, con base amplia y cinturón de marcha si está indicado.

Puntos claves de control (PCC)

- **Pelvis:** facilitar inclinación anterior para iniciar el despegue y controlar la extensión al ponerse de pie.
- **Tronco:** mantener alineación en línea media, evitando flexión o inclinación excesiva.
- **Rodillas:** vigilar alineación con los pies y evitar colapso en flexión o hiperextensión.
- **Pies:** asegurar apoyo plantar completo y distribución simétrica del peso.
- **Miembros superiores:** usar el caminador como apoyo estable; evitar que el paciente tire de él para levantarse.

Objetivo

Facilitar la transición de sedestación a bipedestación, mejorar la transferencia anterior del peso, promover la activación de extensores de cadera y rodilla y alcanzar una postura de pie segura con apoyo.

Evidencia fotográfica







ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Recomendación General

1. **Controla la fatiga y ahorra energía:**
Dosifica la intensidad, intercala descansos adecuados y organiza las tareas diarias alternando actividad con reposo para evitar el agotamiento, apoyándote en ayudas técnicas cuando sea necesario.



2. **Progresión por evolución:**
Avanza según la respuesta funcional del paciente, nunca por el tiempo transcurrido.



3. **Vigila señales de alarma:**
Detener la actividad ante dolor, intolerancia o cambios respiratorios.



4. **Acondicionamiento gradual:**
Introduce ejercicio aeróbico submáximo únicamente en etapas avanzadas y con estabilidad clínica.



5. **Posiciones Clave de Protección - Decúbito supino:**
Mantener alineación neutra, cabeza en línea media y usar soportes para prevenir el pie equino.



6. **Posiciones Clave de Protección - Decúbito lateral:**
Colocar almohadas entre rodillas y tobillos para evitar presión ósea directa.



7. **Posiciones Clave de Protección - Sedestación temprana:**
Iniciar con soporte de tronco y ángulos de 90° en caderas, rodillas y tobillos.



ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

USC INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Conclusiones

Desde el enfoque de las **técnicas neuromusculares**, la fisioterapia desempeña un papel importante en la rehabilitación del síndrome de Guillain-Barré, al abordar las alteraciones de la **fuerza**, el **tono**, la **coordinación** y el **control motor** que comprometen la funcionalidad del paciente.

La **FNP**, la **estabilización rítmica**, los **ejercicios isométricos** y la **movilización pasiva** constituyen estrategias que pueden incorporarse al proceso de rehabilitación, complementándose con actividades de **movilidad** y **entrenamiento funcional** orientadas a favorecer la independencia en las actividades de la vida diaria.

Los resultados reportados por **Gawande et al. (2024)** muestran cambios favorables en la **fuerza muscular**, la **independencia funcional** y la **escala de Hughes** después de 30 días de intervención, evidenciando la evolución descrita en el caso clínico.

En este sentido, el abordaje fisioterapéutico debe ser **individualizado** y **progresivo**, considerando la respuesta neuromuscular, la capacidad funcional y la tolerancia al esfuerzo, con el propósito de favorecer la recuperación del movimiento y la autonomía del paciente.



ODS 3 SALUD Y BIENESTAR